ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

フレイルと高齢重症患者 — 要約

解説「フレイルと高齢重症患者」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

年齢ではなく予備能で語る

CFSは入室前2か月の生活を家族や施設から聞いてつけ、何点で切ったかを必ず添える

CFS×SOFAの2軸で判断する

年齢を閾値にしない。入室と同時に治療の上限を項目単位で決め、迷えば期限付きの試み

家族には「どこへ帰れるか」

死亡率より退院先から話す。退室時・退院時に測り直し、転院の経路を厚く支える

2 測る — 入室前の生活を聞き、カットオフを添える

詳しく

- **フレイル＝ストレスから戻ってこられるかを表す予備能**：併存疾患の数でも障害でも暦年齢でもない。CFSは1〜9の階段で、9は最重度のフレイルではなく生命予後が短い終末期を指す
- **3つの問い（1〜2分）**：移動（買い物に一人で行けたか）・身の回り（入浴・排泄・食事のどこに手が要るか）・この半年の変化。挿管・鎮静された「今」ではなく入室前2か月を、2つ以上の情報源で
- **数字にはカットオフを添える**：同じ414例でCFS≥4なら54%、≥6なら22%（2.5倍）。道具でも違い、同じ患者でCFS 29.8%、Frailty Index 44.8%
- **取れなかったことも書く**：百寿者ではCFSの54.7%が欠損し、欠損は偏って起きる。空欄は「フレイルなし」と誤読されるので「評価不能（理由）」と書き、翌朝に取り直す

3 何が予後を決めるか — 年齢より予備能、死亡より退院先

詳しく

軸	数字	読み方
年齢	選ばれた高齢者（VIP2・百寿者460例）では効かず、DPC 51万例の敗血症では院内死亡8.3%→24.9%（90歳以上）	矛盾しない。年齢は入室の閾値に使わず、家族への説明に正直に使う
退院先	JIPADで80代のICU死亡5.4%、自宅に帰らない40.0%。90代は7.2%と53.1%	「生きて出られるか」より「どこへ帰れるか」
長期生存	自宅以外へ退院した57,652例の4年生存はフレイル32.5%対64.3%（調整HR 1.50）	相対的な影響は65歳未満で最大（HR 1.73）。若さで割り引かない
フレイルは動く	FORECASTで入室時29.8%→退院時54.6%→6か月34.1%	入室時・ICU退室時・退院時の3点で測り直す
施設	JIPAD 80歳以上への生命維持治療は施設で約10倍（標準化治療比0.24〜2.34）	強度を上げても院内生存は変わらない。要るのは利益のある患者を見分けること

4 判断する — 2軸で見て「入れる、ただしここまで」

詳しく

0分 電話で3つの問い ▶ 15分 CFS確定 ▶ 30分 CFS×SOFAで型を見る ▶ 60分 家族と上限を決める

▼

CFS高値

- ×SOFA高値：治療目標の話し合いを早く始め、入室と同時に上限を項目単位で
- ×SOFA低値：軽症に「見える」だけ。VIP2で84歳・SOFA 3の型の30日死亡17%。安易に病棟へ返さない

CFS低値（頑健）

- ×SOFA高値：年齢を理由に断らず通常どおり治療する（93歳・SOFA 4でも7%の型がある）
- 決めきれなければ期限付きの試み（例：72時間）と再評価の項目を家族と先に共有

上限は CPR・挿管・人工呼吸・昇圧薬・RRT を別々に決める。DNARが決めるのは心停止時だけ。制限は看取りではない（Ethicus-2で差し控え後も34.9%が生存退院）

- **家族への伝え方**：①今できること、②いつまで、③その後どうするか、④心停止時の扱い、を分けて約束する
- **入室したら離床とせん妄**：FORECASTでフレイル患者に差がついたのは離床とせん妄だけで、どちらも介入できる。「無理をさせない」に流れず、むしろ強める

5 病態ごとの数字 — 生存は回復ではない

詳しく

病態	知っておく数字	使い方
心停止後	TTM2で6か月死亡 fit 40%・prefrail 75%・frail 84%・severely frail 92%。重度フレイルは予後予測29%なのにWLST 66%	フレイルだけで差し控えを決めず、96時間後の予後予測を予定どおり
敗血症性ショック	OPTPRESS生存者の69.6%が90日後CFS 5以上。最強の予測因子は発症前CFS（1点でOR 2.03）	生存と回復を分けて家族に話す
誤嚥性肺炎	85歳以上の80.1%が自宅に帰らない	全診断の80代40.0%の約2倍。全体の数字では甘すぎる
血液悪性腫瘍	12か月生存は入室時CFS 1–3で34%、6–9で14%	断る根拠ではなく治療目標の話し合いの材料

6 家族と退院、落とし穴

詳しく

- **退院支援は転院の経路を厚く**：フレイルの悪影響は他院転院（HR 1.56）とリハビリ転院（1.52）で大きく、高齢者施設（0.94）では有意でない。CFSの推移と治療の上限を情報提供書に書く
- **指針は答えをくれない**：SCCM 2026・ESICM 2025とも強い推奨はゼロ。一致したのは老年医学的ケアモデルだけ
- **予言を自分で当てない**：制限が転帰を作り「やはり予後不良」と確かめる輪が回る。制限の理由と範囲を項目ごとに残す。CFSを門前払いの道具にしない

- ☐ **年齢の隣にCFS**とカットオフを書く
- ☐ **DNAR**の一語で上限を済ませない
- ☐ **退室時のCFS**を入室時から転記しない
- ☐ **事後解析の関連**で治療を変えない

出典：本編の主要文献（Cecconi ICM 2024；VIP2；FORECAST；Mehta CCM 2025；Munshi ICM 2024；JIPAD高齢者 ICM 2024；Shiotsuka 2026；TTM2二次解析；OPTPRESS事後解析；Sekiya JIC 2026；SCCM 2026；

ESICM 2025 ほか）。数字は教育目的の記載で、原著と照合して使ってください。